



Faculté de médecine de Sousse
Cycle de préparation au concours de résidanat

Pr BOUGHAMOURA Lamia

Pr KABAILI Raoudha

Août 2025

Sujet 21 : Diarrhées chroniques : Physiopathologie, Diagnostic

1. La diarrhée chronique chez l'enfant :

- A. Est définie par une durée supérieure à 3 semaines
- B. Peut avoir un début néonatal
- C. Peut s'accompagner d'une croissance normale
- D. Nécessite toujours un bilan étiologique
- E. Peut indiquer un régime d'exclusion à vie

2. Le retentissement clinique de la diarrhée chronique peut être évalué par :

- A. L'indice de corpulence (Poids / Taille ²)
- B. Le périmètre brachial
- C. Le stade pubertaire
- D. Le nombre des selles
- E. L'âge osseux

3. Le bilan de retentissement d'une diarrhée chronique comprend :

- A. Une électrophorèse des protéines
- B. Une cholestérolémie
- C. La fonction rénale
- D. Une calcémie
- E. Mesure de la stéatorrhée

4. L'évaluation biologique de la carence nutritionnelle dans le cadre des diarrhées chroniques de l'enfant comporte :

- A. Le dosage de la stéatorrhée
- B. Le dosage de la calprotéctine fécale
- C. L'électrophorèse des protéines
- D. Le dosage du cholestérol
- E. Une ostéodensitométrie

5. Le syndrome du côlon irritable :

- A. Est un trouble de la motricité colique
- B. Peut-être déclenché par l'excès d'ingestion de lipides
- C. Se manifeste entre 6 mois et 4 ans
- D. S'accompagne d'un retard pubertaire
- E. Entraîne un retard de la maturation osseuse

6. Le côlon irritable peut s'accompagner de :

- A. Un syndrome dysentérique
- B. Des douleurs abdominales
- C. Des selles glaireuses avec des fragments des végétaux non digérés
- D. Une alternance diarrhée constipation
- E. Un syndrome inflammatoire biologique

7. Le syndrome du côlon irritable est évoqué devant :

- A. Un âge < 6 mois
- B. La présence de fragments non digérés dans les selles
- C. L'alternance diarrhées/constipation
- D. Une stagnation pondérale
- E. Un état général conservé

8. La diarrhée prandiale :

- A. Se déclare durant les premières semaines de vie
- B. Est plus fréquente chez les nourrissons au sein
- C. S'accompagne des selles glairo-sanglantes
- D. S'accompagne des coliques
- E. Entraîne une hypotrophie

9. Chez le nourrisson, la diarrhée prandiale du premier trimestre est évoquée devant :

- A. L'association à des régurgitations
- B. Des selles survenant immédiatement après les tétées
- C. L'absence de retentissement sur la courbe staturo-pondérale
- D. L'irritation du siège
- E. La disparition de la diarrhée lors de la mise sous allaitement artificiel

10. Une malabsorption est évoquée devant :

- A. Un syndrome hémorragique
- B. Des crises de tétanie
- C. Des manifestations respiratoires
- D. Des œdèmes des séreuses
- E. Des douleurs osseuses

11. Les signes biologiques évoquant une malabsorption :

- A. Une hyperphosphorémie
- B. Une hypocalcémie
- C. Une hypercalciurie
- D. Une hypomagnésémie
- E. Une hypovitaminose B 12

12. Chez l'enfant, le mécanisme des diarrhées chroniques est :

- A. Une mal digestion au cours de la mucoviscidose
- B. Un trouble fonctionnel de la motricité colique dans les diarrhées motrices
- C. Une fermentation au cours des gastro-entérites
- D. Une malabsorption dans les α - β lipoprotéïnémies
- E. Une diarrhée osmotique dans les allergies aux protéines de lait de vache

13. Chez l'enfant, des diarrhées chroniques par malabsorption peuvent se voir au cours :

- A. Des parasitoses digestives
- B. Des gastro-entérites virales
- C. Du déficit immunitaire combiné sévère
- D. De la malnutrition protéino-calorique sévère
- E. De la mucoviscidose

14. Chez l'enfant, la diarrhée chronique par malabsorption peut être due à :

- A. Un déficit en zinc (acrodermatitis entéropathica)
- B. Une giardiose intestinale
- C. α - β lipoprotéïnémie
- D. Une mucoviscidose
- E. Une infection par le VIH

15. Les diarrhées par intolérance au lactose sont caractérisées par :

- A. La fréquence des formes primitives
- B. L'apparition suite à une diarrhée aiguë
- C. L'association à des douleurs abdominales et des flatulences.
- D. Des selles acides irritantes
- E. Une plus grande fréquence chez le nourrisson

16. La maladie cœliaque :

- A. Est une entéropathie auto immune par intolérance au gluten
- B. Survient particulièrement chez le groupe HLA DQ2
- C. A une prévalence de 1/200 pour les formes typiques
- D. Est plus fréquente chez le sexe masculin
- E. Peut se manifester par une aphtose buccale récidivante

17. Le diagnostic de maladie cœliaque chez l'enfant :

- A. Se fait de plus en plus fréquemment devant des formes dissociées
- B. Doit être évoquée devant une anémie carencielle rebelle au traitement
- C. Peut se faire suite à des manifestations neuropsychiatriques
- D. Nécessite une endoscopie digestive haute dans tous les cas
- E. Peut être retenu devant des critères cliniques et sérologiques uniquement.

18. Chez l'enfant, une maladie cœliaque peut se manifester par :

- A. Des douleurs abdominales récurrentes
- B. Un retard statural isolé
- C. Des bronchopneumopathies récidivantes
- D. Une modification du caractère (comportement)
- E. Des selles volumineuses et pâteuses

19. Le diagnostic de maladie cœliaque chez l'enfant :

- A. Est confirmé par des Ac anti trans glutaminases > 10 fois la normale
- B. Est confirmé par la positivité des Ac anti endomysium
- C. Repose sur l'aspect histologique des biopsies duodénales
- D. Impose un régime sans gluten à vie
- E. Expose au risque de lymphome du tube digestif

20. Au cours du suivi de la maladie cœliaque :

- A. Le seigle est autorisé
- B. L'orge est interdite à vie
- C. Le rattrapage statural est possible
- D. Le gluten est réintroduit à la puberté
- E. Un retard pubertaire peut se voir

21. Dans la giardiase :

- A. La diarrhée est due à une mal digestion
- B. Il existe une hypotrophie
- C. Le diagnostic est confirmé par la sérologie
- D. L'atrophie villositaire est toujours partielle
- E. Le traitement repose sur le metronidazol

21. L'allergie aux protéines de lait de vache peut se manifester par :

- A. Une insuffisance cardiaque
- B. Un eczéma
- C. Un choc anaphylactique
- D. Une dyspnée sifflante
- E. Une dénutrition

22. Les manifestations cliniques au cours de l'APLV :

- A. Peuvent être secondaires à une réaction d'hypersensibilité retardée
- B. Peuvent faire suite à une réaction d'hypersensibilité immédiate IgE médiée
- C. Apparaissent parfois dès la 1^{er} ingestion des PLV
- D. Posent le diagnostic différentiel avec la maladie de Crohn
- E. Indiquent l'exclusion des PLV

23. Les diarrhées chroniques secondaires à une allergie aux protéines de lait de vache :

- A. Surviennent classiquement au-delà de 6 mois
- B. Sont secondaires à une réaction d'hypersensibilité retardée
- C. S'accompagnent souvent d'IgE spécifiques positifs.
- D. Peuvent induire une dénutrition avec hypotrophie
- E. Indiquent une épreuve d'Eviction- Réintroduction

24. La prise en charge des diarrhées secondaires à une APLV repose sur :

- A. Les hydrolysats de caséine (lait sans PLV)
- B. Le lait sans lactose
- C. Une corticothérapie prolongée
- D. Les anti-diarrhéiques
- E. L'abstention thérapeutique

25. Dans les diarrhées par fermentation, les selles sont :

- A. Sanglantes
- B. A pH < 5
- C. Aqueuses
- D. Mousseuses
- E. Mastic

26. L'entéropathie exsudative :

- A. Peut être due à une maladie de Waldmann
- B. Peut se manifester par une polysérite
- C. Entraîne une hyper cholestérolémie
- D. Peut entraîner une lymphopénie
- E. Est confirmée par une clairance de l' α 1- antitrypsine < à 20 mL/jour.

27. L'évaluation de la sécrétion du pancréas exocrine se fait par :

- A. Le breath test
- B. La recherche de stéatorrhée
- C. Le dosage de l' α 1antitrypsine
- D. Le dosage de l'élastase fécale
- E. L'étude du pH fécal

28. Chez un enfant atteint de mucoviscidose :

- A. Il existe une dysrégulation du transport ionique du chlore et du potassium au niveau des cellules épithéliales.
- B. Les selles sont pâteuses, pâles et fétides
- C. Le mucus anormalement visqueux induit une obstruction des canaux pancréatiques
- D. Le taux d'élastase fécale est anormalement élevé
- E. Le test à la sueur montre un taux de chlore supérieur à 60meq/l.

29. La mucoviscidose :

- A. Se transmet sur le mode autosomique dominant
- B. Est due à des mutations du gène CFTR
- C. Comporte une insuffisance pancréatique exocrine
- D. Est caractérisée par une sueur salée
- E. S'associe à des malformations cardiaques

30. Chez l'enfant, la maladie de Crohn :

- A. Est moins fréquente que la rectocolite hémorragique
- B. Peut se révéler par un retard de croissance
- C. Peut s'accompagner des signes extra-digestifs
- D. Touche avec prédilection le rectum
- E. Justifie la réalisation d'une entéro-IRM

31. Dans les diarrhées d'origine colique, les selles sont :

- A. Glaireuses
- B. Sanglantes
- C. Graisseuses
- D. En bouse de vache
- E. Fétide

32. Parmi les causes des diarrhées graves à début néonatal :

- A. L'atrophie micro-villositaire congénitale
- B. La diarrhée chlorée congénitale
- C. La diarrhée sodée congénitale
- D. La dysplasie épithéliale
- E. L'intolérance au lactose

Cas Clinique N° 1 :

Nourrisson âgé de 10 mois, hospitalisé pour PEC d'une diarrhée chronique.

ATCDs : issu des parents consanguins ; Terrain d'atopie familiale ; né à terme, eutrophique ; 3 épisodes de dyspnée sifflante, traités en ambulatoire. Il reçoit un allaitement artificiel depuis l'âge de 3 mois et un régime diversifié depuis l'âge de 6 mois.

Depuis 2 mois, il présente une diarrhée faite de selles graisseuses à raison de 5 à 6 fois par jour.

Examen : Poids à -2 DS ; Taille : normale ; conjonctives pâles ; eupneique, auscultation cardio pulmonaire normale. Le reste de l'examen est sans particularité.

1. Devant cette diarrhée chronique, quel bilan de retentissement demandez-vous ?

- A. Une NFS + ferritinémie
- B. Une calcémie
- C. Une sérologie cœliaque
- D. Le taux d'Ig E spécifiques
- E. Le taux de chlore sudoral

2. Quels sont les diagnostics étiologiques à évoquer devant ce tableau clinique ?

- A. Une mucoviscidose
- B. Un déficit immunitaire
- C. Une atrophie microvillositaire
- D. Une APLV
- E. Une maladie cœliaque

3. Le diagnostic de mucoviscidose est fortement suspecté devant :

- A. La consanguinité
- B. La présence de terrain d'atopie dans la famille
- C. Le retentissement sur le poids
- D. L'atteinte respiratoire
- E. L'absence d'hippocratisme digital

4. Le diagnostic est confirmé par :

- A. Le bilan pancréatique
- B. Le dosage de la stéatorrhée
- C. Un taux de chlore sudorale > 60 meq/l
- D. La biologie moléculaire
- E. Le test au D Xylose

Cas clinique N°2 :

Fille âgée de 14 ans, hospitalisée pour exploration d'une diarrhée chronique

Elle est née à terme, eutrophique à la naissance. DPM : correct.

Dans ses ATCDs : mère suivie pour un diabète de type 1

Elle présente une diarrhée qui traine depuis plusieurs années, non améliorée par des traitements symptomatiques. Elle se plaint des douleurs abdominales récurrentes et des épisodes de constipation. Elle n'a pas encore eu ses règles.

Examen : pâleur cutanéo muqueuse ; P = -2.5DS ; T= -2.5 DS ; ongles et cheveux cassants

Auscultation cardio pulmonaire : normale

Abdomen légèrement ballonné ; Stade pubertaire : P0 ; S0

Examens complémentaires :

NFS : GB= 11000 ; Hb= 9.3 gr/dl ; VGM= 60 ; TCMH= 27 ; Rétic= 45000 ; Plaq= 220.000

Calcémie= 2.0 mmol/l ; cholestérol= 3.1 mmol/l ; Urée = 4 mmol/l ; Créatinine= 35 µmol/l ; Albuminémie= 25 gr/l ; Taux d'immunoglobuline A : normal

1. La patiente présente un syndrome de mal absorption devant :

- A. ATCD de maladie auto immune dans la famille
- B. L'alternance diarrhée constipation
- C. L'hypoalbuminémie
- D. L'hypocalcémie
- E. L'anémie microcytaire

2. Le diagnostic de maladie cœliaque est fortement suspecté, devant :

- A. Le diabète de type 1 chez la mère
- B. L'alternance diarrhée constipation
- C. Les troubles des phanères
- D. Le retard pubertaire
- E. L'âge

3. Pour confirmer votre diagnostic, vous demandez :

- A. Le dosage de la calprotectine fécale
- B. La sérologie cœliaque
- C. La fibroscopie digestive haute
- D. Une entéro-IRM
- E. Une colonoscopie

- 4. Le diagnostic de maladie cœliaque est confirmé, quelle serait votre prise en charge ?**
- A.** Régime hypo allergénique
 - B.** Régime à base d'orge
 - C.** Traitement martial
 - D.** Supplémentation calcique
 - E.** Régime sans gluten à vie